

VARIANTE E

1. L'angine avec streptocoque du groupe A (SGA) s'associe avec :

- a) leucopénie ou leucocytose avec lymphocytose
- ☒ b) leucocytose avec neutrophilie
- c) leucopénie ou leucocytose sont évocateurs d'angine bactérienne
- ☒ d) Indices d'inflammation (protéine C-réactive, fibrinogène) augmentées
- e) VSH diminue

2. Les manifestations cliniques typiques pour la mucoviscidose sont :

- a) toux sèche
- ☒ b) diarrhée chronique avec stéatorrhée
- ☒ c) iléus méconial
- ☒ d) ictère prolongé
- e) obésité

3. L'angine virale ne peut être caractérisée par :

- a) a. fièvre oscillante, l'anorexie, la dysphagie,
- b) b. rinorhée, toux sèche
- ☒ c) c. leucocytose
- ☒ d) d. neutrophilie
- e) e. microvésicules des piliers

4. Les dernières affirmations sur l'épiglottite sont vraies :

- ☒ a) l'étiologie est Hemophilus influenzae, Pneumocoque
- b) c'est la plus facile forme de laryngite
- ☒ c) à une évolution suraiguë
- ☒ d) signes cliniques sont dyspnée inspiratoire marquée, stridor
- e) à une évolution chronique

5. Le traitement des laryngites implique :

- a) beta2 mimétique sélective nébulisée
- ☒ b) humidification de l'atmosphère
- ☒ c) corticoterapie parentérale
- d) trachéotomie
- e) antibiothérapie obligatoire

6. Les dernières affirmations sur la bronchiolite sont fausses :

- ☒ a. une restriction pulmonaire s'associe
- b. bronchiolite est caractérisée par une inflammation de la paroi bronchiolai
- ☒ c. l'agent étiologique commun est Haemophilus influenzae
- ☒ d. associé une bronchoscrtion importante
- e. le wheesing évoque une bronchiolite

7. La mucoviscidose est soupçonnée dans la présence de :

- ☒ a) la respiration sifflante récurrente
- ☒ b) prolapsus rectal récidivant

- c) diabète
- d) goût doux de la sueur
- e) hypertension portale

8. Critères d'admission d'un enfant avec bronchiolite sont :

- a) moins de 3 mois d'âge
- b) wheezing audible sans stéthoscope
- c) le manque de possibilité d'une surveillance correcte
- d) comorbidités associées
- e) la saturation en oxygène > de 98%

9. Le diagnostic différentiel du wheezing s'effectue avec :

- a) reflux gastro-œsophagien
- b) laryngite chronique
- c) malformations diaphragmatique
- d) compressions extrinsèques (anneau vasculaire, tumeurs)
- e) mucoviscidose

10. Examens complémentaires dans les pneumonies peuvent révéler :

- a) leucocytose avec neutrophilie dans les pneumonies virale
- b) leucocytose dans les pneumonies bactériennes
- c) leucopénie avec lymphocytose-pneumonies virales
- d) leucopénie dans les pneumonie virales
- e) dyslipidémie

11. Le contrôle de l'asthme existe s'il y a :

- a) plus de 3 crise/ semaine
- b) moins de 2 crise/semaine
- c) sans limitation de l'activité
- d) besoin du traitement : moins de 2 fois/semaine
- e) besoin du traitement : moins de 2 fois/jour

12. Le traitement médicamenteux de fond de l'asthme consiste en :

- a) inhalation journalière de bêta-1 agonistes
- b) oxygénothérapie pour maintenir Sat O₂ ≥ 95%
- c) physiothérapie thoracique
- d) corticostéroïdes inhalateurs
- e) les bronchodilatateurs à longue durée d'action

13. Le syndrome Marfan est caractérisée par :

- a) Déficit staturale
- b) grande taille
- c) l'hyperlaxité ligamentaire
- d) l'agitation psychomotrice
- e) respiration sifflante

14. Les causes de convulsions afebrile chez le nourrisson et le jeune enfant sont :

- ☒ a) l'épilepsie
- ☒ b) troubles hydroélectrolytiques (natrémie, calcémie) ←
- c) frisson fébrile
- d) abcès cérébral
- e) thrombophlébite cérébrale

15. Les suivantes sont de causes de convulsions fébriles chez le nourrisson, sauf :

- ☒ a) dyselectrolytémie ←
- b) infection neuroméningée
- c) abcès cérébral
- ☒ d) tumeur cérébrale ←
- e) thrombophlébite cérébrale

16. L'anémie macrocytaire est associée avec :

- a) thalassémie ←
- ☒ b) carence en vitamine B12
- ☒ c) carence de l'acide folique
- d) l'hyperthyroïdie ←
- e) fièvre

17. L'anémie ferriprive :

- ☒ a) est la première cause d'anémie en pédiatrie ←
- b) est une anémie macrocytaire
- ☒ c) est une anémie microcytaire
- ☒ d) est une anémie hypochrome
- e) est une anémie normochrome

18. Les signes suivantes peut suggérer une leucémie aiguë lymphoblastique :

- ☒ a) pâleur
- b) hypotermie
- ☒ c) hématurie
- ☒ d) angine récidivante
- e) hyperglycémie

19. Le diagnostic du neuroblastome se fait par :

- a) la radiographie cérébrale ←
- ☒ b) le dosage des catécholamines urinaires
- c) l'échographie pulmonaire
- ☒ d) d.l'analyse histologique d'un fragment tumoral ←
- e) immunogramme

*20. Les malformations cardiaques congénitales prédisposent à l'endocardite à l'exception :

- a) Tétralogie de Fallot
- ☒ b) communication inter auriculaire ostium secundum ←

- c) communication inter ventriculaires
 - d) l'insuffisance mitrale
 - e) cardiomyopathie hypertrophique obstructive
21. Le diagnostic positif de l'endocardite se base sur :
- a) existence obligatoire d'une malformation cardiaques congénitales
 - b) présence d'un souffle systolique ou l'apparition de nouveaux souffles
 - c) hémocultures positives
 - d) évidence des végétations à l'échographie
 - e) CT scan cérébral
22. La myocardite s'associe avec :
- a) bruits cardiaques étouffés, souffle systolique
 - b) wheezing
 - c) hypovoltage du complexe QRS
 - d) le cœur en « flash », avec d'angles obtus par rapport au diaphragme
 - e) silhouette cardiaque allongée
- *23. Les causes des péricardites sont les suivantes, sauf :
- a) les maladies du collagène
 - b) le traumatisme sternal
 - c) la radiothérapie
 - d) les infections avec *S. pneumoniae*
 - e) tuberculose
24. Persistance du canal artériel est associée avec :
- a) shunt droite à gauche
 - b) shunt de gauche à droite
 - c) cyanose
 - d) souffle holo systolique
 - e) diabète
25. Dans la D-transposition classique de gros vaisseaux :
- a) l'aorte émerge du ventricule gauche
 - b) l'artère pulmonaire émerge du ventricule gauche
 - c) l'aorte émerge du ventricule droit
 - d) il ne faut pas exister un mélange du sang
 - e) la cyanose est grave dès la naissance
26. Le traitement curatif de l'endocardite utilise les médicaments suivants
- a) Amoxicilline 50 mg/kg (max. 3 g) par voie orale
 - b) Pénicillines ou l'Oxacilline, plus la Gentamicine, injectable
 - c) Vancomycine 40 mg/kg/jour, max. 2 g/kg en 4 doses
 - d) Erythromycine 20 mg/kg par voie orale
 - e) Clindamycine 10 mg/kg (max. adulte 300 mg) par voie orale

27. Le tableau clinique de la tétralogie Falot comprend :

- a) la cyanose profonde et position du 'squatting' (accroupissement) ✓
- b) tachycardie
- c) crises hypoxiques ✓
- d) hyperpyrexie
- e) doigts hippocratiques

28. L'étiologie des vomissements aigus comprend :

- a) les infections ORL
- b) hypovitaminose A ✓
- c) méningite
- d) infections respiratoires
- e) syndrome Down ✓

29. Le reflux gastro-œsophagien pathologique :

- a) débute généralement précoce dès les premiers jours de vie
- b) se caractérise par des régurgitations ✓
- c) est défini comme le passage volontaire du contenu gastrique
- d) représente la première cause de vomissements chez le nourrisson
- e) associe obligatoirement de la diarrhée

30. Les manifestations extra digestives du reflux gastro-œsophagien sont :

- a) toux à prédominance nocturne ✓
- b) laryngites récurrentes
- c) protéinurie
- d) convulsions
- e) fièvre

31. Les affirmations suivantes sur l'infection par *Helicobacter pylori* sont vraies :

- a) est l'une des infections les plus rares dans le monde entier
- b) *Helicobacter pylori* est une bactérie Gram négatif ✓
- c) provoque l'ulcère gastroduodénal ✓
- d) la transmission est aéroportée
- e) la gastrite antrale à H p est diagnostiquée par des lésions nodulaires typiques

32. Les régimes thérapeutiques de première ligne dans l'infection avec *Helicobacter pylori* sont :

- a) Amoxicilline (50 mg / kg / jour) + Clarithromycine (15 mg / kg / jour) + IPP, 2 doses/jr
- b) Amoxicilline (50 mg / kg / jour) + Métronidazole (30-40 mg / kg / jour) + IPP, deux doses / jour
- c) Amoxicilline (100 mg / kg / jour) + Métronidazole (50 mg / kg / jour) + sels de bismuth, doses / jour
- d) IPP + Amoxicilline (50 mg / kg / jour) 5 jours, ✓
- e) IPP + Clarithromycine (15 mg / kg / jour)

33. Les complications possibles de l'infection à *Helicobacter pylori* sont :

- a) la gastrite chronique
- ☒ b) la gastrite aiguë
- c) la métaplasie intestinale
- d) la glomérulonéphrite
- ☒ e) l'apparition d'un carcinome gastrique

34. Les affirmations suivantes sur la diarrhée aiguë sont incorrectes :

- a) diarrhée aiguë est une affection fréquente
- b) la déshydratation aiguë est la principale complication
- c) causes les plus fréquentes de diarrhées sont bactériennes
- d) le traitement repose sur la réhydratation par voie orale et la réalimentation précoce doivent être parfaitement expliquées aux parents
- e) les douleurs abdominales sont vraiment rares associées avec diarrhée

35. Signes cliniques de déshydratation intracellulaire sont :

- a) Fontanelle déprimée
- b) Pli cutané persistant
- c) Temps de recoloration cutané allongé
- d) Hypotonie des globes oculaires
- e) Fièvre

36. Les antibiotiques recommandés, en fonction de l'étiologie, pour les diarrhées aiguës :

- a) Shigelle : ampicilline (100mg/kg/j)
- b) Salmonelle : ceftriaxone (50 mg/kg/j)
- c) Shigelle : ibuprofène (20-30 mg/kg/j)
- d) *Campylobacter jejuni* : érythromycine (50 mg/kg/j per os)
- e) Salmonelle : Gentamycine 40 mg/kg/j

37. Les causes de diarrhée chronique énumèrent :

- a) Allergie aux protéines de lait de vache
- b) mucoviscidose
- c) syndrome Marfan
- d) infection à Salmonelle
- e) infestation avec *Echinococcus granulosus*

38. La maladie cœliaque :

- a) est une entéropathie IgE médiée
- b) est une entéropathie médiée par le système immunitaire
- c) survient chez les patients ayant un déficit sélectif en IgA
- d) survient chez des personnes génétiquement prédisposées (DQ2 ou DQ8).
- e) a des symptômes respiratoires

39. Les anticorps utilisés pour le diagnostic de la maladie coeliaque s'énumèrent :

- a) IgA antitransglutaminases (TGA)
- b) IgM antitransglutaminases
- c) IgG anti-endomysium en cas de déficit en IgA
- d) IgM antigliadine ✓
- e) Les anticorps anti-peptides de la gliadine désaminée

40. Les protéines qui causent l'allergie sont :

- a) bêta-lactoglobuline
- b) gamma-lactoglobuline
- c) caséine
- d) albumine
- e) immunoglobuline G ✓

41. L'hépatite chronique avec virus B, dans la période inactive, non répliquative, est caractérisée par la présence des :

- a) Ag HBs
- b) Ac anti-HBs ✓
- c) Ag HBe ✓
- d) ADN viral PCR ✓
- e) Ac anti-HBe ✓

42. L'hépatite C chronique a les suivantes caractéristiques sérologiques positives :

- a) Ac IgM anti-VHC ✓
- b) Ac IgG anti-VHC
- c) Ig M-HBe
- d) Ig G-anti HBe
- e) ARN viral par PCR

43. Les porteurs VHB ont :

- a) Ag HBs positif ✓
- b) Ac IgM anti-HBe positifs ✓
- c) Ac IgM anti-HBe négatifs
- d) Ac IgM anti-delta positifs
- e) Ac IgG anti-VHD positifs

44. Les manifestations cliniques de la giardiase sont :

- a) un appétit vorace
- b) les douleurs épigastriques ✓
- c) halitose sulfureuse le matin
- d) la perte de poids ✓
- e) l'urticaire

45. Les déclarations suivantes sont vraies à propos de GNA poststreptococcique

- a) l'étiologie sont des souches particulières (néfritigène) de streptocoque bêta-hémolytique de groupe A
- b) Les cultures d'urine relèvent leucocyturie, cylindrurie, bactériurie ✓

- c) l'entrée: respiratoire ou cutané
- d) maladie "des complexes immuns circulantes"
- e) les œdèmes se produisent pendant l'angine streptococcique

46. Le syndrome urinaire dans GNA poststreptococcique est caractérisé par :

- a) oligurie ✓
- b) hématurie ✓
- c) protéinurie modérée ✓
- d) densité urinaire réduite
- e) protéinurie sélectif au début ✓

47. Le tableau clinique de l'infection urinaire chez le nourrisson et petit enfant :

- a) fièvre ✓
- b) ictère
- c) vomissements, diarrhée ✓
- d) urine nuageux (pyurie) ✓
- e) purpura

48. Le syndrome néphrotique (SN) se caractérise par :

- a) protéinurie massive, sélective
- b) œdème généralisés massive
- c) hypoprotéinémie ✓
- d) dysprotéinémie
- e) hyperalbuminémie

49. Les manifestations majeures du RAA (rhumatisme articulaire aigu) sont les suivantes :

- a) polyarthrite aiguë fugace et mobile
- b) cardite
- c) céphalée
- d) nodules sous cutanés
- e) érythème facial

50. Le traitement du syndrome néphrotique (SN) par thérapie immunosuppressive est indiqué en cas de :

- a) SN stéroïdes sensible avec rechutes souvent ✓
- b) SN stéroïdes -sensible avec événements V d'intolérance à corticostéroïdes
- c) formes de SN secondaire, sensible aux stéroïdes
- d) formes de SN congénital et familiale
- e) formes de SN stéroïdes -sensible ou sans stéroïdes -intolérance

- 1) BD
- 2) BCD
- 3) CD
- 4) ACD
- 5) ABC
- 6) ACD
- 7) ABC
- 8) ACD
- 9) ADE
- 10) BCD
- 11) BCD
- 12) XDE
- 13) BC
- 14) AB
- 15) AXD
- 16) BC
- 17) ACD

- 18) ACD
- 19) BD
- *20) B
- 21) BCD
- 22) ACDE
- *23) B
- 24) BD
- 25) BCE
- 26) ABC
- 27) ACE
- 28) ABCD
- 29) ABD
- 30) ABX
- 31) BCE
- 32) AB
- 33) ACE
- 34) CE
- 35) XED

- 36) ABD
- 37) AB
- 38) BXD
- 39) ACE
- 40) AC
- 41) AE
- 42) ABE
- 43) AD
- 44) CED
- 45) AXDC
- 46) AB
- 47) ABXC
- 48) ABC
- 49) ABD
- 50) AB